EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88089
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-08 09:21:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ROSA EMILIA GARRIDO CORREA			**RUN**	: 7.337.936-9
F.Nac	: 09-05-1949	**Edad**	: 75 AÑOS, 1 MES	**Género**	: Femenino
Dirección	: La Estrella 0636 Nueva Vida			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 999066598		
Fecha Ingreso	: 2024-07-05	**Fecha Egreso**	: 2024-07-08 09:21:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) EPA cardiogenico resuelto
a) IC en vias de compensacion (FEVI a precisar
2) EPOC
3) FA en TACO
4)HTA
5) DM2 NIR
6) ITU en tratamiento

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J81-EDEMA PULMONAR (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente cona ntec descritos, consulta en SU el 04/07 por cuadro de 12 hrs de evolucion de disnea progresiva y desaturacion en domicilio, se describe con mala perfusion hacia distal, polipneica, ECG al ingreso se describe con FA c/RVR. Se procede a inicio de BIC de NTG en vista de edema pulmonar en curso, sumado a manejo depletivo, se decide ingreso a UPC para manejo.
Durante estadia se procede a continuacion de terapia depletiva, sumado a inicio de BB. Desde la esfera infecciosa se describe inflamatoria, URC con desarrollo de E coli multisensible.
Durante su estadia estable, con destete progresivo de O2 suplementario
Paciente HDN estable, afebril, con FC fluctuante entre 69 y 101 en las ultimas 24 hrs, sin peak febril, normosaturando ambiental desde el 06/07, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin episodio de nauseas y/o vomitos, diuresis (+), pero no cuantificado en hoja de enfermeria, deposiciones (-)

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Actualmente cursando su dia N°4 hospitalizado, dia N°4 ceftriaxona, en condiciones de continuar manejo via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Paciente actualmente cursando con ITU con desarrollo de E coli multisensible, se continuara con administracion de ATB para completar 3 dias de tratamiento, se continuara con hospitalizacion via HODOm

4) Cardiovascular: Estable, sin requerimientos de O2 suplementario, con edema en regresion, se solicitara ecocardiograma de caracter ambulatorio

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisetada 30°
2. Regimen diabetico hiposodico a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr EV por 3 dias
4. Carvedilol 6,25 mg, medio comp c/12 hrs VO por 3 dias
5. Furosemida 40 mg c/12 hrs VO por 3 dias
6. Omeprazol 20 mg al dia VO por 3 dias
7. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
8. Brexotide 2 puff c/12 hrs por AC
9. Examenes de control 11/07
10. Acenocumarol acorde a esquema TACO
11. PEndiente toma de ecocardiograma

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO